

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : حياه حامد عبدالمجيد عثمان

المحافظة : شمال سيناء الحي / المدينة : الحسنه

رقم البطاقة : 26808112601223 رقم التليفون : 01102309041 تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 11-08-1968 المهنة : حداد

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

**قسم العلاج :
الاورام**

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي مثبط CDK4/6 و فلفسترات [14469]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالم
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حياة حامد عبدالمجيد عثمان National ID: 26808112601223	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

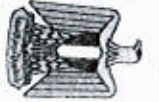
المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي CDK4/6 inhibitor and fulvestrant

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٣٤/١٠
٢١٨٠٨١١٢٦٠١٢٣٣
رَبِّهِ مَنَزَل

مُتَوَجِّهَةٌ
مُسَلِّمَةٌ
رَأْسُ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْمُودِ السَّمْعَانِ
الْبَطَانَةُ سَارِيَّةٌ حَتَّى ٢٠٣١/١٠/٢٥



مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

حَيَاة

حَامِدُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَمَّانُ الْقَاعُودِ

٦ شَ مَحْمُودِ عَلَى الرَّاقِي

بُورَاقِ الدُّرُودِ - الْحِجْرَةِ

٢ ٦٨ ٠ ٨ ١ ١ ٢ ٦ ٠ ١ ٢ ٢ ٣

KU8396439



Presidence Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

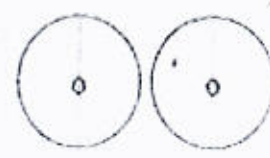
البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID: 1- Name : **دواء خاتم عبد المجيد عثمان** Sex: Female 3- Medical number: 83263175 Old Med : 622-2025
2-ID number: 26808112601223 Patient Age: 57 Y

Denon MBC
to bones
polychemo



Family history	Family history +ve	Phone	Phone 01102309041	BMI	BMI 47	REASON OF MDT	REASON OF MDT Denon MBC
marital status	Marital status Married	NRS Score	NRS Score 1	GROUP	GROUP AI	Date of MDT	Date of MDT 2025-04-30
Co morbidity	Co morbidity +ve	Menopausal status	Menopausal status Postmenopausal	Initial STAGE	Initial STAGE T3N1M1		

Clinical data

Breast Imaging : It breast BIRADS 5 UOQ malignant looking solid lesion with segmental area of microcalcification			Mets Workup : ct cap: bilateral pulmonary nodules few osseous lesion no sizable hepatic deposits		
BX IDC ER PR HER2 Neu SISH Ki67 LSM	ER 8/8 PR 3/8 HER2 Neu SISH Ki67 LSM	PR 3/8 HER2 Neu SISH Ki67 LSM	HER2 Neu 0 SISH ER Ki67 LSM	SISH ER Ki67 LSM	Ki67 LSM
T 3		N 1		M 1 bones	

Sonomammography

PATIENT HISTORY

bone scan:two veterbral lesions

MDT OUTCOME & PLAN

mbc to bones (denovo)
for ai - zometa/3m
palliative radiotherapy to dv7& lv3

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	NUTRITION
SURGERY			
Psychiatric			



Patient Name :	الأستاذة / حياة حامد عبدالمجيد عثمان	Request No. :	13007286
Patient No. :	26808112601223	Request Date :	27/01/2025
Path No. :	360/25	Verification Date :	13/02/2025
Sex :	Female	Financial Category :	أورام داء السلام - نفقة الدولة
Age :	38 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data

Left breast mass

Nature of specimen

Tru cut biopsy, collected at 26/1/2025, 10:30 am

Gross examination

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: Minimal
- * Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural invasion: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 80 %tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Weak nuclear reaction in 5 %tumor cells (Allred score 3/8)
- * HER2: No membrane reaction in of tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 15 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis

Left breast mass, Tru cut biopsy:

Verified by :

Dr.Heba Hasan





Patient Name : الأستاذة / حياة حامد عبدالمجيد عثمان
Patient No. : 26808112601223
Path No. : 360/25
Sex : Female
Age : 38 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007286
Request Date : 27/01/2025
Verification Date : 13/02/2025
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Invasive duct carcinoma, Grade II

IPT:

- * ER: Positive (score 8/8).
- * PR: Positive (score 3/8).
- * HER2: Negative (score 0).
- * Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Signature

Dr. Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 22/02/2025 09:51:22

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Women's Health Outreach Program

Name: HAIAT HAMED ABDEL MAGUID

Date: 26-01-2025

Bilateral Full field Digital Mammography and high resolution ultrasound examination

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast :

- Fairly dense mammary parenchyma .(ACR density b).
- UOQ asymmetrical density with pleomorphic microcalcifications in area measuring about 13x7x12 cm reaching to nipple
- Ultrasound revealed between 2-3 o'clock shows
- irregular hypoechoic solid lesion seen measures 13 x10mm it is 5 cm from nipple at 13 mm from skin
- posterior to lesion there area of alter of tissue echogenicity containing microcalcifications, the area measures about 9x5cm it is away from lesion by 7mm and skin by 7mm and nipple by 6 cm
- Retro areolar prominent ducts is seen connected to lesion .the duct contain echogenic content with calcification
- Two enlarged pathological axillary lymph nodes .it measures 20x15mm &17x12mm

Right breast

- Fairly dense mammary parenchyma (ACR density. b).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 5): UOQ malignant looking solid lesion with segmental area of microcalcifications for biopsy
(biopsy was taken in same sitting)

Right breast (BIRADS 1): normal study .

Best regards,
Dr. Marwa M.Hassan

Name: Mrs. Hayat Hamed Abdel-Mageed Osman

Date: 15/4/2025

ID:2225012447

Acc.:5115889

Referring / Hospital Awram Dar El-Salaam

Tc-99m MDP whole body bone scan

Technique:

- Whole body images were acquired 180 minutes after IV injection of ~15 mCi of the tracer.

Findings:

- Focal spots of active tracer uptake are seen in DV7, LV3.
- Degenerative changes of the spine are seen.
- Arthritic changes of knees are noted.
- Both kidneys are normally visualized.

Opinion:

- *Two vertebral lesions suggestive of metastatic osseous deposits, for follow up bone scan.*

Truly yours

Prof. Dr. Ahmed Kandeel. MD

Prof. of Nuclear Medicine, faculty of medicine, Cairo University

Printed by KH 16/04/25 14:11:00



Patient Name: Hayal Hamed Abd Al Maguid Othman	Date : 22/03/2025
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 622/2025	Pat. ID: 98559

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:**

- Reported case of left breast cancer.

I Chest:

- Left breast UOQ asymmetrical parenchymal densities.
- Enlarged left axillary level I and II lymph nodes reaching 1.5 X 2.6 cm.
- Few bilateral pulmonary nodules reaching 6 mm at inferior lingula.
- No sizable pulmonary masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavitary lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross enlargement.

II Abdomen & pelvis:

Incomplete pelvic cuts:

- The liver is enlarged showing homogenous parenchymal attenuation. No sizable focal lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.
- Few dorsolumbar sclerotic foci reaching 9 mm at L3.

Opinion:

- Reported case of left breast cancer revealed:
- Bilateral pulmonary nodules for follow up.
- Few osseous lesions for bone scan.
- No sizable hepatic deposits.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



08/23/2026

MDT FORM

Name:	Haya Hammed Abdalmajeed /	MRN:	3822
Age:	58 Y	ID:	26808112601223
Menopausal Sta	post	Phone:	01102309041
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	-ve	Reason Of MDT:	metastatic

Clinical Data:

BX: idc 2

ER: 8/8 **PR:** 3/8 **HER2:** -ve **KI67:**

Sonomammography:

Mets Workup:

4/2025 :denovo metastatic breast cancer to bone + lung
palliative rth to bone
femara 18 months
zometa / 3m

7/2026 bone scan :pd
8/2026 ct cap :pd

History:

Recommendations:

for ibrance +fasoladex

MDT Outcome & Plan

ibrance +fasoladex
zometa every 3 ms after dental assessment

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr Hahan Ezzat					